COMUNIDADE
Saúde Conectada

LIPEDEMA

Comunidade Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O lipedema é uma doença vascular crônica que causa o aumento desproporcional de gordura nas pernas e algumas vezes nos braços, provocando **dor** na região afetada. A doença tem causas genéticas e atinge principalmente as mulheres em idade reprodutiva.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

CAUSA

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Predominância estrogênica *
Inflamação
Alterações metabólicas

↓

Genética

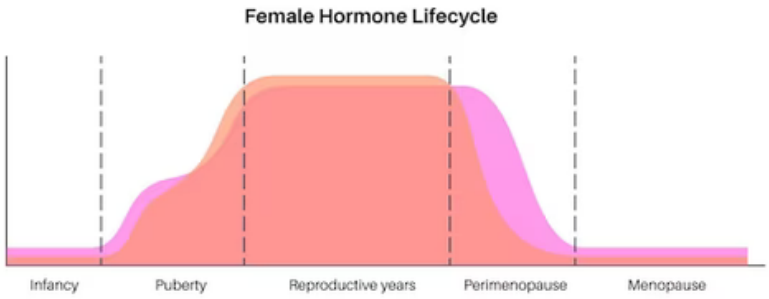
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PICOS DE ESTROGÊNIO

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Gravidez
Puberdade
Perimenopausa



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

SINAIS E SINTOMAS

- Desconforto,
- Cansaço,
- Hematomas frequentes,
- Edemas (inchaço)
- Alteração articulares
- Dor nas pernas e outras regiões afetadas
- Hipotermia na pele
- Piora dos sintomas ao longo do dia e também no verão
- Hiperflexibilidade - hipermobilidade articular
- Sinal do garrote

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

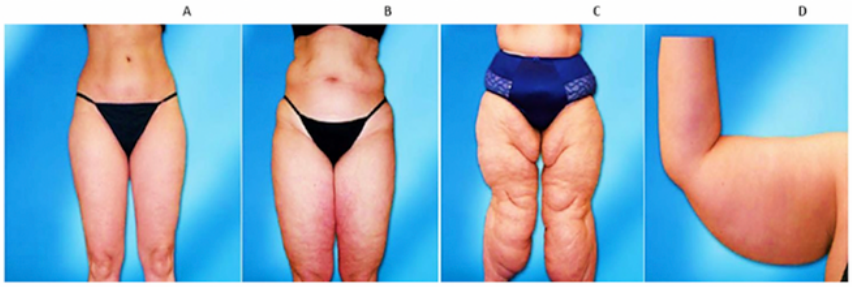
A doença evolui em cinco estágios: inicia-se pela região pélvica e segue por quadris, nádegas, coxas e pernas, com possibilidade de acometer o sistema linfático

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Aumento de volume simétrico e bilateral, principalmente dos membros inferiores.
É desproporcional ao restante do corpo.
Aumento progressivo.
Em alguns casos pode acometer também os braços.
Geralmente poupa mãos, pés e tronco
Não resolve apenas com restrição calórica e atividade física
40% das mulheres com lipedema tem peso normal ou são magras

COMUNIDADE
Saúde
Conectada



lipedema staging. **(A)** Stage I - skin appears smooth, but the thickened subcutaneous tissue contains small nodules. **(B)** Stage 2 - skin has an irregular texture, subcutaneous nodules occur that vary from the size of walnut to an apple. **(C)** Stage 3 - deformed lobular fat deposits form, especially around thighs & knees: may cause considerable distortion of limb profile. **(D)** Stage 4 - lipedema with lymphoedema (lipolymphoedema). Jeziorek, et al., (2022).

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

No Brasil, a prevalência é de 12,3%
8,8 milhões de mulheres adultas brasileiras entre 18 e 69 anos podem ser portadoras de lipedema
Afeta até 11% das mulheres em todo mundo
90% das mulheres sentem dor
87% tem sofrimentos que afetam a qualidade de vida
É subdiagnosticada
Não tem cura - mas tem controle

Prevalência e fatores de risco para lipedema no Brasil

Lipedema prevalence and risk factors in Brazil

Alexandre Campos Moraes Amato[1], Fernando Campos Moraes Amato[1], Juliana Lelis Spirandeli Amato[1], Daniel Augusto Benitti[2]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

LIPEDEMA X LINFEDEMA

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Enquanto o linfedema é uma condição originária do sistema **linfático**, o lipedema diz respeito ao acúmulo de **gordura**;

O lipedema costuma atingir ambos lados de maneira simétrica, enquanto o linfedema pode atingir somente o lado esquerdo ou direito;

Enquanto no lipedema a quase totalidade de casos diz respeito a mulheres, o mesmo não se repete com o linfedema.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada
E TRATAMENTO

DIAGNÓSTICO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O lipedema foi descrito pela primeira vez em 1940 pelos doutores Edgar Van Nuys Allen, cirurgião cardiovascular conhecido pelo teste de Allen, e Edgar Alphonso Hines Jr. na Mayo Clinic[1,2], na sessão *Vascular Clinics*; por isso, a síndrome é denominada Allen-Hines[3]. Desde então, o lipedema foi caracterizado como uma deposição anormal de gordura em glúteos e pernas bilateralmente, que pode ser acompanhada por edema ortostático[1,2]. A fisiopatologia e a epidemiologia do lipedema ainda são pouco compreendidas[4,5]. Além disso, o lipedema só foi incluído recentemente na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) (EF02.2 e BD93.1Y)[6], de forma que ainda não faz parte do currículo médico acadêmico brasileiro nem do currículo vascular especializado. Sendo assim, é ainda frequentemente confundido com outras condições mais frequentes, como a obesidade, lipodistrofia ginoide e linfedema[7,8], e raramente é diagnosticado na primeira consulta médica[4].

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

CÓDIGO
EF 02.2

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- **Clínico**
- Ultrassom
- DEXA (composição corporal),
- Ressonância Magnética
- Tomografia Computadorizada
- Linfocintilografia
- Bioimpedância

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tabela 1. Versão final do Questionário de Avaliação Sintomática de Lipedema.

Questionário de Avaliação Sintomática do Lipedema (QuASiL)											
Nome: Data:											
Gradue seus sintomas de 0 (não) a 10 (muito). Se o critério for variável, selecione a intensidade máxima que você sente.											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
As áreas afetadas são dolorosas? (0 não / 10 muito)											
As áreas afetadas são sensíveis ao toque ou à pressão? (0 não / 10 muito)											
Você tende a ter manchas roxas facilmente e frequentes nas pernas? (Hematomas, equimoses) (0 não / 10 muito)											
Você sente "pressão" ou "tensão" nas pernas? (0 não / 10 muito)											
Sente as pernas "quentes" ou sensação de "queimação"? (0 não / 10 muito)											
Sente suas pernas frias? (0 não / 10 muito)											
Tem câimbras musculares? (0 não / 10 muito frequente)											
Sente peso nas pernas? (0 não / 10 muito)											
Sente cansaço nas pernas? (0 não / 10 muito)											
Sente inchaço nas pernas? (0 não / 10 muito)											
Tem "irritações" na pele? (0 não / 10 muita)											
Sente coceira? (0 não / 10 muita)											
Tem dificuldade para caminhar? Alguma limitação de movimento? (0 não / 10 gravemente)											
Como a condição afeta sua qualidade de vida? (0 nada / 10 gravemente)											
Está satisfeita com a aparência das pernas? (Atenção: 0 muito satisfeita / 10 insatisfeita)											

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Pontuação de 0 a 150

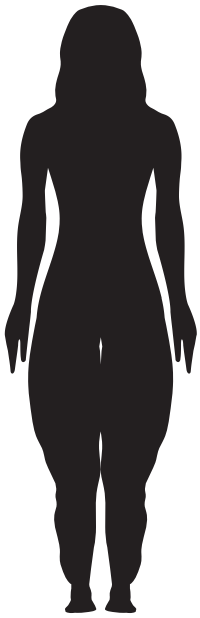
ARTIGO ORIGINAL • J. Vasc. Bras. 19 • 2020 • https://doi.org/10.1590/1677-5449.200049 COPIAR

Tradução, adaptação cultural e validação do questionário de avaliação sintomática do lipedema (QuASiL)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

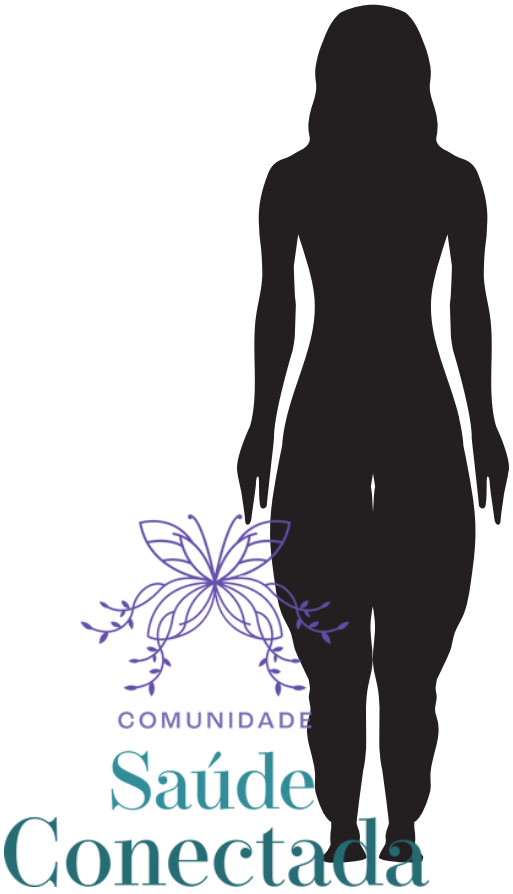
Teste do lipedema

COMUNIDADE Saúde Conectada



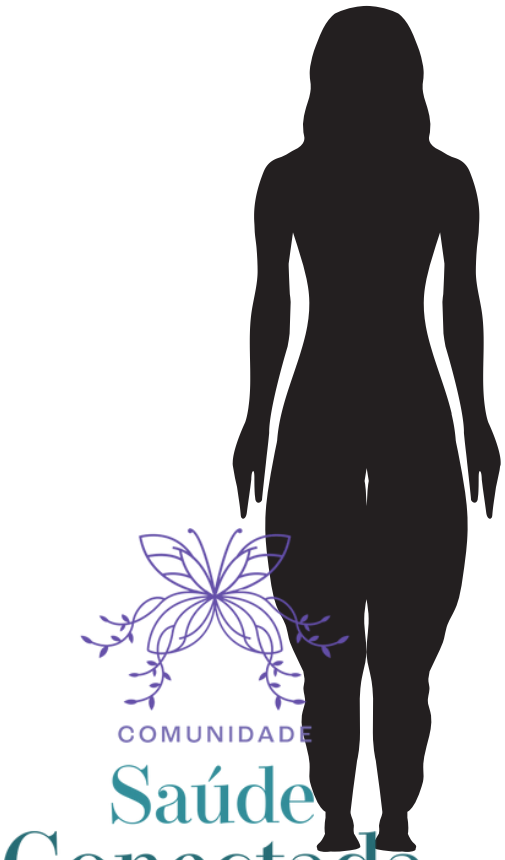
Pergunta	Resposta	Escore
Você sente que algo está errado nas suas pernas, mas não sabe o que? (p1)	Sim, minhas pernas são grandes, parecem colunas/tronco de árvore e tenho gordura no tornozelo.	3
	Sim, minhas pernas são maiores (comparativamente) que o resto do meu corpo.	2
	Sim, minhas pernas são grandes e proporcionais ao resto do meu corpo.	1
	Não, minhas pernas estão bem.	0
A parte de baixo do corpo é maior e desproporcional ao tronco/parte superior do corpo? (p2)	Sim, a parte de baixo do meu corpo é nitidamente desproporcional à parte de cima/tronco. O tamanho da minha calça é pelo menos 3 vezes maior que o tamanho de minha camisa.	2
	Sim, meu corpo inferior é discretamente desproporcional ao meu tronco/parte de cima. O tamanho da minha calça é de 1 a 2 vezes maior que o tamanho de minha camisa.	1
	Não, a parte de cima do meu corpo/tronco é maior que a parte de baixo do meu corpo. O número do tamanho da minha camisa é maior que o número da minha calça.	0
	Não, a parte de cima e de baixo do meu corpo são proporcionais. O número da minha camisa e calça são os mesmos.	0

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



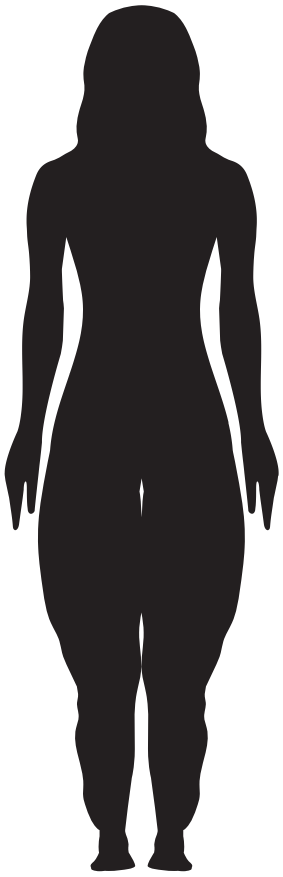
Você tem problema para perder peso, principalmente a parte de baixo do corpo? (p3)	Sim, não consigo perder peso por nada que eu faça, principalmente nas minhas coxas/pernas, quadril e/ou braços, que parecem sempre aumentar.	2
	Sim, tento muito e só pareço perder peso no tronco/parte de cima do corpo, frequentemente excluindo braços.	1
	Não, com dieta e exercício consigo perder peso. O peso/gordura parece sair proporcionalmente do meu corpo inteiro	0
	Não, não tenho problema de peso ou dificuldade para perder peso. Normalmente tenho um peso estável.	0
Durante a puberdade, você ganhou peso principalmente nas coxas/pernas, quadris, nádegas ou braços? (p4)	Sim, ganhei muito peso durante a puberdade, principalmente nas minhas coxas e pernas, quadris, nádegas e/ou braços	2
	Sim, ganhei algum peso na minha puberdade. As coxas/pernas, quadris, nádegas e/ou braços pareciam ficar maior que outras partes do meu corpo.	1
	Não, ganhei algum peso durante a puberdade que foi distribuído no corpo inteiro e não somente nas coxas/pernas, quadris, nádegas e braços.	0
	Não, ganhei um pouco de peso, mas perdia facilmente com dieta e exercício.	0
	Não, eu não ganhei peso. Meu peso foi bem estável durante a puberdade.	0

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Durante ou logo após a gravidez/amamentação, você ganhou peso ou teve mudança nas suas coxas/pernas, quadris, nádegas e/ou braços? (p5)	Sim, ganhei muito peso (> 23kg), principalmente nas coxas/pernas, quadris, nádegas e/ou braços durante ou logo após a gestação e/ou amamentação.	2
	Sim, ganhei entre 16-23kg, um pouco nas coxas/pernas, quadris, nádegas e/ou braços logo após a gestação e/ou amamentação.	1
	Não, ganhei peso normalmente (11-15kg), nenhum peso extra foi localizado nas coxas/pernas, quadris, nádegas e/ou braços durante ou logo após a gestação e/ou amamentação.	0
	Não, ganhei menos peso do que o esperado ou perdi peso durante ou logo após a gestação e/ou amamentação.	0
	Não aplicável, não tive gestação.	0
Durante a menopausa, você ganhou peso ou teve mudança nas suas coxas/pernas, quadris, nádegas e/ou braços? (p6)	Sim, ganhei bastante peso, e minhas coxas/pernas, quadris, nádegas e/ou braços cresceram.	2
	Sim, ganhei peso, e minhas coxas/pernas, quadris, nádegas e/ou braços cresceram um pouco.	1
	Não muito, ganhei um pouco de peso, mas foi distribuído igualmente no meu corpo todo ou na minha barriga.	0
	Não, não ganhei peso.	0
	Não aplicável, ainda não passei pela menopausa.	0

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Suas pernas doem? (p7)	Sim, minhas pernas são muito sensíveis. São dolorosas ou sinto queimando mesmo quando não são tocadas.	3
	Sim, minhas pernas são dolorosas e incômodas com qualquer toque.	2
	Às vezes, minhas pernas doem ao pressionar ou ficar muito tempo de pé.	1
	Não, minhas pernas não doem.	0
Você tem inchaço nas pernas? (p8)	Sim, minhas pernas parecem inchadas quase o tempo todo. Ficam piores no calor e quando úmido, e o inchaço não melhora ao elevar as pernas. O inchaço é igual dos dois lados.	2
	Sim, minhas pernas frequentemente parecem inchadas, mas às vezes melhoram com elevação. O inchaço ocorre dos dois lados.	1
	Não, minhas pernas quase não incham, incham pouco no calor ou no tempo úmido ou somente após viagem de avião ou no período menstrual, mas rapidamente voltam ao tamanho normal, principalmente quando elevo as pernas. E/Ou somente uma das pernas incham.	0
	Não, eu raramente sinto inchaço nas pernas.	0
Suas pernas ou braços formam hematomas facilmente? (p9)	Sim, minhas pernas e braços formam hematomas muito facilmente, eu nem percebo onde consigo eles.	2
	Sim, minhas pernas e braços formam hematomas às vezes, com um contato mínimo.	1
	Não formo hematomas facilmente.	0

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

ARTIGO ORIGINAL • J. Vasc. Bras. 19 • 2020 • https://doi.org/10.1590/1677-5449.200114 COPIAR

Criação de questionário e modelo de rastreamento de lipedema

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

TRATAMENTO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- **Dieta anti - inflamatória**
- Intestino e fígado
- Fitoterápicos
- Atividade física
- Medicamentos - emagrecimento / RI
- Meias de compressão
- Massagem e drenagem
- Cirurgia - lipoaspiração
- Fisioterapia
- Psicoterapia

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

DESINFLAMAÇÃO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

AIC 2023 | Rosen Shingle Creek Orlando, FL **June 1-3**

Managing pain and inflammation using diet and lifestyle changes in patients with LIPEDEMA

Y. ETEMADI
University of Western States, Portland, Oregon

Scan for more info

INTRODUCTION

Lipedema (LP) is a chronic condition that is observed predominantly in the female population. It is referred to as the disease of fat legs. The advancement of the disease occurs during physical transitions caused by hormones during different stages of a woman life, such as puberty, childbirth, and sometimes during the menopausal stage (Felmerer et al., (2020). It is a is a hereditary condition.

SYMPTOMS

- Enlargement of legs, not feet
- Pain & tenderness
- Easy bruising
- Tight pea-size fat accumulation
- Resistant to diet and exercise

The etiology of LP is unknown, with numerous hypotheses being emphasized. LP received an International Classification of Diseases (ICD) code in February 2022 (World Health Organization, 2022). LP cases are hard to treat, primarily because women are often misdiagnosed and do not receive appropriate treatment for many years. It is an inadequately investigated disorder, primarily characterized by a "being fat" stigma and neglected by medical professionals due to a lack of knowledge and the absence of clear diagnostic criteria (Warren et al., 2007)

11% Women Globally

THERAPIES

- The proposed LP treatment aims to reduce the symptoms and avert the progression of the disease. While LP is not the same as lymphedema, the proposed treatment is similar: manual lymphatic massage, exercise, compression, and manual adipose tissue therapy. Liposuction is also a recommended treatment, especially for stages II, III (Czerwińska et al., 2022).
- Decongestive physiotherapy (DC) is widely used for people with cancer due to the high accumulation of fluid. DC includes daily manual lymphatic massage and drainage, compression therapy, skincare, and movement therapy, and it also attempts to promote lymphatic flow by stimulating muscle construction (Liao, et al 2013) . Since LP is a condition of overworked lymph vessels, leakage and accumulation of lymphatic fluids, and DC are also used to treat it.
- Individually-sized compression garment is used supplementary along with DC. The mean 1cm3 leg volume loss using DC and compression garment drive lymphatic fluid away from the tissues, resulting in reduction of volume (Szolnoky et al., 2008)
- The cytokines profile of the LP group before and after a year of the liposuction. After the surgery the following cytokines decreased: interferon alpha (IFNα) pre- 49.29 vs. post-liposuction 42.15 pg/mL, and IL-34 pre- 237 vs. post-liposuction 115 pg/mL (Wolf et al., 2021)

RESULTS

Lipedema:
- Symmetrical increments of adipose tissue at the lower part of the body, excluding feet.
- Confused or misidentified with obesity or lymphedema

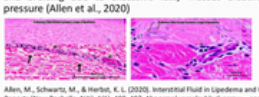
Lymphedema:
- An uneven distribution of fat: painful swelling in one or more limbs due to damage or blockage in lymphatic system.

OBESITY:
- Characterized by excess body fat that can lead to cardiovascular disease and diabetes.

lipedema stages. **(A)** Stage I - skin appears smooth, but the thickened subcutaneous tissue contains small nodules. **(B)** Stage II - skin is characterized by irregular bumps that occur that vary from the size of walnut to an apple. **(C)** Stage III - tissue nodules coalesce, forming large masses, especially on thighs & knees; may cause considerable distortion of limb profile. **(D)** Stage IV - lipedema with lymphedema (lipolymphedema). Jeziorek, et al., (2022).

LIPEDEMA AND THE LYMPHATIC SYSTEM

- The LP group had an increased lymphatic propulsion rate compared with patients affected by LD. The increased propulsion rate is caused by the increased capillary permeability due to inflammation, which is normally associated with dilated veins and varicose that is often observed in women with LP (Rasmussen et al. 2021)
- Vitamin C helps LP patients with capillary fragility caused by inflammation and fat accumulation. Vitamin C is crucial to preventing perturbation in the capillary structure and also avoiding capillary leakage into the tissue space and bruising due to excessive fatty masses creating chronic mechanical pressure (Allen et al., 2020)



Allen, M., Schwartz, M., & Herbst, K. L. (2020). Interstitial Fluid in Lipedema and Control Skin. Women's Health Reports (New Rochelle, N.Y.), 1(1), 480–487. Abnormal vessels: black arrow – endothelial cells, white arrow – enlarged perivascular space.

LIPEDEMA AND PAIN

- Bodily pain, which is generally expressed by LP patients, is one of the primary symptoms. It is daily pain in the lower extremities, which increases with contact and pressure
- 6% out of 120 women with LP claimed that they didn't experience any pain, 33% had moderate pain, 34% observed severe daily pain, and 14% suffered from highly severe pain, with some claiming that the pain caused them emotional disturbances and difficulties in leading a normal life. (Dudek, et al., 2016). LP patients reported having chronic leg pain in stage I (25%), stage II (52%), and stage III (62%). Stage III participants expressed higher pain than stages I and II, including pain at light touch. In a biopsy of the thigh area, there was a change the total level of Nerve Growth Factor (NGF) when compared between the different stages of LP. a stage I LP skin sample had a significantly lower amount of NGF than a sample from the control group, and at stage III, NGF outscored the control category (Chakraborty et al., 2022)
- The treatment of painful diabetic neuropathy was exclusively demonstrated in the study carried out by Trippe et al. (2016) employing folate, B12, and B6. The pain with diabetic retinopathy can also be addressed using vitamin C due to its anti-inflammatory and antioxidant properties (Bai et al., 2021)

LIPEDEMA AND THE DIET

- The ketogenic diet (KD) reduces neuropathic pain and lowers inflammatory cytokines in LP (Ruskin et al., 2021)
- Patients lost weight and had improved quality of life, but pain returned after stopping KD. The mechanism of the KD diet is not precise in reducing pain levels; it can be an elevation in ketone bodies or a shift in macronutrient intake. The pain might be reduced due to the anti-inflammatory properties of the KD diet and the high intake of antioxidant vegetables and omega 3 (Jeziorek et al., 2022).
- Even though some women with LP are aware of their diagnoses and try different weight-loss diets, make intelligent choices towards more healthy foods, and efficiently manage the consumption of sugar and processed food; also, extra weight curbs one's ability to absorb, metabolize and distribute micronutrients

(no. 1 & no. 2) with lipedema before & after the LCHF diet. Patient 1 & 2: (A) - photo before intervention; (B) - photo after intervention.

LIPEDEMA AND INSULIN RESISTANCE

One essential characteristic that differentiates LP from obesity is fat location: LP's fat is localized in the lower part of the body, not around the waist, and women with LP have a lower risk of metabolic diseases despite high BMI

- Due to gynoid SAT fat distribution vs. android, women with LP have a lower risk of T2D. Despite high BMI, gynoid SAT has a protective effect (Beltran, Herbst., 2017)
- A high BMI is usually associated with altered lipid metabolism and a high triglyceride profile, and therefore it possesses a higher risk of cardiovascular diseases, but body fat distribution is vital in the lipoprotein profile (Mekki et al.,1999)
- The region of fat distribution influences the lipid profile and the postprandial response to high-fat meal; therefore, the lipid profile, risk of CVD, and insulin response of women with LP gynoid obesity is closer to a non-obese person than a person with android obesity (Mekki, et al., 1999)

CONCLUSIONS

Adopting a nutritional diet and healthy lifestyle is crucial for women with LP, as they have a positive impact on the level of pain and inflammation as well as the severity of the disease; this mechanism was described in the review. Even though LP resembles obesity, it is a different condition and has to be addressed in terms of both low and high BMI. While the volume of research about LP is growing, it is crucial to understand that each LP patient has their individual journey and must rely on the therapies that work for them. Used LP studies include only a small number of participants, and many are not blinded. Therefore, this review highlighted the areas that might encourage women and healthcare professionals to create their own research of therapeutics for LP. More research on the condition is necessary to have a clearer understanding of its biomarkers. As the gap in LP literature and healthcare professional knowledge about diagnosing LP is an indisputable fact, it is crucial to follow the recommendations already established by existing research to improve the quality of life for LP patients.

REFERENCES

Allen, M., Schwartz, M., & Herbst, K. L. (2020). Interstitial Fluid in Lipedema and Control Skin. Women's Health Reports (New Rochelle, N.Y.), 1(1), 480–487. **Bai**, A., Abdullahi, F., Namar, J., Eid, A., Abbas, M., Sandesh, R., Naz, S., Shahid, S., Aseem, F., & Memon, S. (2020). The Role of Vitamin C in Reducing Pain Associated with Diabetic Neuropathy. Cureus, 13(10). **Beltran, K.**, & **Herbst, K. L** (2017). Differentiating lipedema and Dercum's disease. International Journal of Obesity, 41(2), 240. **Chakraborty**, A., Crescenzi, R., Usman, T. A., Reyna, A. J., Garza, M. E., Al-Ghadban, S., Herbst, K. L., Donahue, P. M. C., & Ratkowski, J. M. (2022). Indications of Peripheral Pain, Dermal Hypersensitivity, and Neurogenic Inflammation in Patients with Lipedema. International Journal of Molecular Sciences, 23(19). **Czerwińska**, M., Tevatiancic, J., & Hamsafar-Kaczan, R. (2022). A Scoping Review of Available Tools in Measurement of the Effectiveness of Conservative Treatment in Lipedema. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(16). **Dudek**, J. E., Białaszek, W., & Ostaszewski, P. (2016). Quality of life in women with lipedema: a contextual behavioral approach. Quality of Life Research : An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation, 25(2). **Felmerer**, G., Stylianaki, A., Hägerling, R., Wang, A., Strobel, F., Hollmén, M., Lindenblatt, N., & Gousopoulos, E. (2020). Adipose Tissue Hypertrophy, An Aberrant Biochemical Profile and Distinct Gene Expression in Lipedema. Journal of Surgical Research, 253, 234–245. **Jeziorek**, M., Szuba, A., Rojewska, K., & Regulska-Ilow, B. (2022). The Effect of a low-Carbohydrate, High-Fat Diet versus Moderate-Carbohydrate and Fat Diet on Body Composition in Patients with Lipedema, Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 15, 2745. **Liao**, S. F., Li, S. W., Hwang, W. Y., Chen, S. T., Kao, S. J., Chen, D. R., & Wei, T. S. (2013). The efficacy of complex decongestive physiotherapy (CDP) and predictive factors of lymphedema severity and response to CDP in breast cancer-related lymphedema (BCRL). The Breast, 22(5). **Mekki**, N., Christofidis, M. A., Charbonnier, M., Atlan-Gepner, C., Defoort, C., Juhel, C., Borel, P., Portugal, H., Pauli, A. M., Vialettes, B., & Lairon, D. (1999). Influence of obesity and body fat distribution on postprandial lipemia and triglyceride-rich lipoproteins in adult women. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 84(3). **Rasmussen**, J. C., Aldrich, M. B., Fife, C. E., Herbst, K. L., & Sevick, M. E. M. (2022). Lymphatic function and anatomy in early stages of lipedema. Obesity (19307381), 30(7). **Ruskin**, D. N., Sturdevant, I. C., Wyss, L. S., & Masino, S. A. (2020). Ketogenic diet effects on inflammatory allodynia and ongoing pain in rodents. Scientific Reports, 11(1). **Szolnoky**, G., Nagy, N., Kovács, R. K., Csiszár-Kátai, E., Szabó, A., Bársony, K., Balogh, M., & Kemény, L. (2008). Complex decongestive physiotherapy decreases capillary fragility in lipedema. Lymphology, 41(4). **Trippe**, R. S., Ramrattan, L. W., Carole, M. V., & Tipa, E. (2016). Nutritional management of patients with diabetic peripheral neuropathy with 5-methyltetrahydrofolate pyridoxal-5-phosphate: results of a real-world patient experience trial. Current Medical Research & Opinion, 32(2), 293–297. **Warren**, A. G., Janz, B. A., Borud, L. J., & Slavin, S. A. (2007). Evaluation and Management of the Fat Leg Syndrome. Plastic and Reconstructive Surgery, 119(3). De **Wolf**, S., Deud, J. W., Hollmén, M., Felmerer, G., Kim, D. S., Vasella, M., Grünherz, L., Giovanoli, P., Lindenblatt, N., & Gousopoulos, E. (2021). A Distinct Cytokine Profile and Stromal Vascular Fraction Metabolic Status without Significant Changes in the Lipid Composition Characterizes Lipedema. International Journal of Molecular Sciences, 22(3).

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to sincerely thank the teachers from UWS who gave me the most profound understanding of the subject and made a massive difference in my world of nutrition.

CONTACT INFORMATION

Yana Etemadi, MS, NC
(949) 306 7756
etemadint@gmail.com
FoodAsMedicine.online

SCAN ME

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

06 December 2021: Articles

Lipedema Can Be Treated Non-Surgically: A Report of 5 Cases

Unusual clinical course, Challenging differential diagnosis, Unusual setting of medical care, Educational Purpose (only if useful for a systematic review or synthesis)

Alexandre Campos Moraes Amato [1ABCDEF*], Daniel Augusto Benitti [3BE]

DOI: 10.12659/AJCR.934406
Am J Case Rep 2021; 22:e934406

COMUNIDADE Saúde Conectada

Tratamento clínico - medidas dietéticas anti-inflamatórias, exercício físico aquático regular, drenagem linfática manual e fitoterápicos antioxidantes em doses de uso regular

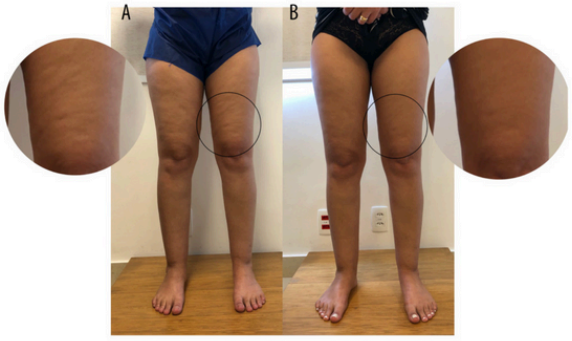


Figure 2.. *Patient with stage 1 lipedema before (A) and after (B) treatment, showing significant aesthetic improvement of gynecoid lipodystrophy (cellulitis), although it was not the main objective of the treatment.*

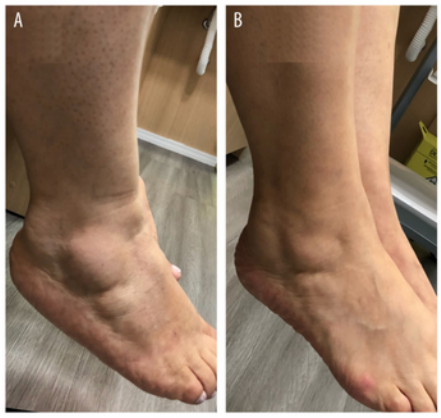


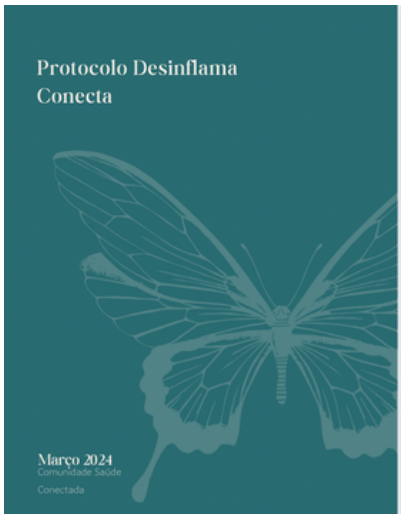
Figure 3.. *Decrease in painful fat nodules in the lateral malleolus in a patient with stage 1 lipedema. (A) Before. (B) After.*

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Front Immunol. 2023 Jul 28:14:1223264. doi: 10.3389/fimmu.2023.1223264. eCollection 2023.

Lipedema stage affects adipocyte hypertrophy, subcutaneous adipose tissue inflammation and interstitial fibrosis

COMUNIDADE Saúde Conectada



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

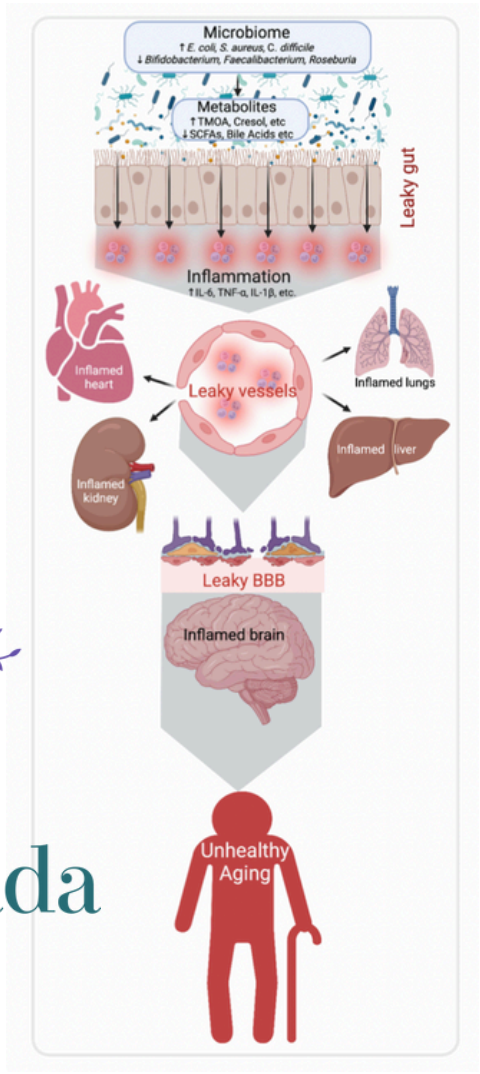
INTESTINO

COMUNIDADE Saúde Conectada

Review > J Autoimmun. 2018 Aug:92:12-34. doi: 10.1016/j.jaut.2018.05.008. Epub 2018 Jun 1

Connecting the immune system, systemic chronic inflammation and the gut microbiome: The role of sex

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE

Saúde Conectada

Clinical Interventions in Aging

Dovepress
open access to scientific and medical research

Open Access Full Text Article

EXPERT OPINION

Treating Leaky Syndrome in the Over 65s: Progress and Challenges

Protocolo de desinflamação + imersão intestino

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

> Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Oct 31:13:1000094. doi: 10.3389/fendo.2022.1000094 eCollection 2022.

Is subcutaneous adipose tissue expansion in people living with lipedema healthier and reflected by circulating parameters?

Pamela A Nono Nankam [1], Manuel Cornely [2], Nora Klöting [1], Matthias Blüher [1 3]

Lipedema may be considered a model for healthy expandability of subcutaneous adipose tissue (SAT). This condition is characterized by the disproportional and symmetrical SAT accumulation in the lower-body parts and extremities, avoiding the abdominal area. There are no circulating biomarkers facilitating the diagnosis of lipedema. We tested the hypothesis that women living with lipedema present a distinct pattern of circulating parameters compared to age- and BMI-matched women. In 26 women (Age 48.3 ± 13.9 years, BMI 32.6 ± 5.8 kg/m2; lipedema group: n=13; control group: n=13), we assessed circulating parameters of glucose and lipid metabolism, inflammation, oxidative stress, sex hormones and a proteomics panel. We find that women with lipedema have better glucose metabolism regulation represented by lower HbA1c (5.55 ± 0.62%) compared to controls (6.73 ± 0.85%; p<0.001); and higher adiponectin levels (lipedema: 4.69 ± 1.99 mmol/l; control: 3.28 ± 1.00 mmol/l; p=0.038). Despite normal glycemic parameters, women with lipedema have significantly higher levels of total cholesterol (5.84 ± 0.70 mmol/L vs 4.55 ± 0.77 mmol/L in control; p<0.001), LDL-C (3.38 ± 0.68 mmol/L vs 2.38 ± 0.66 mmol/L in control; p=0.002), as well as higher circulating inflammation (top 6 based on p-values: TNFSF14, CASP8, EN-RAGE, EIF4EBP1, ADA, MCP-1) and oxidative stress markers (malondialdehyde, superoxide dismutase and catalase). Our findings suggest that the expected association between activation of inflammatory and oxidative stress pathways and impaired glucose metabolism are counterbalanced by protective factors in lipedema.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > J Prev Med Hyg. 2022 Oct 17;63(2 Suppl 3):E36-E43.
doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2S3.2745. eCollection 2022 Jun.

Modern vision of the Mediterranean diet

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

Saúde Conectada

> Nutrients. 2021 Jan 25;13(2):358. doi: 10.3390/nu13020358.

Potential Effects of a Modified Mediterranean Diet on Body Composition in Lipoedema

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Case Reports > Life (Basel). 2021 Dec 15;11(12):1402. doi: 10.3390/life11121402.

Management of Lipedema with Ketogenic Diet: 22-Month Follow-Up

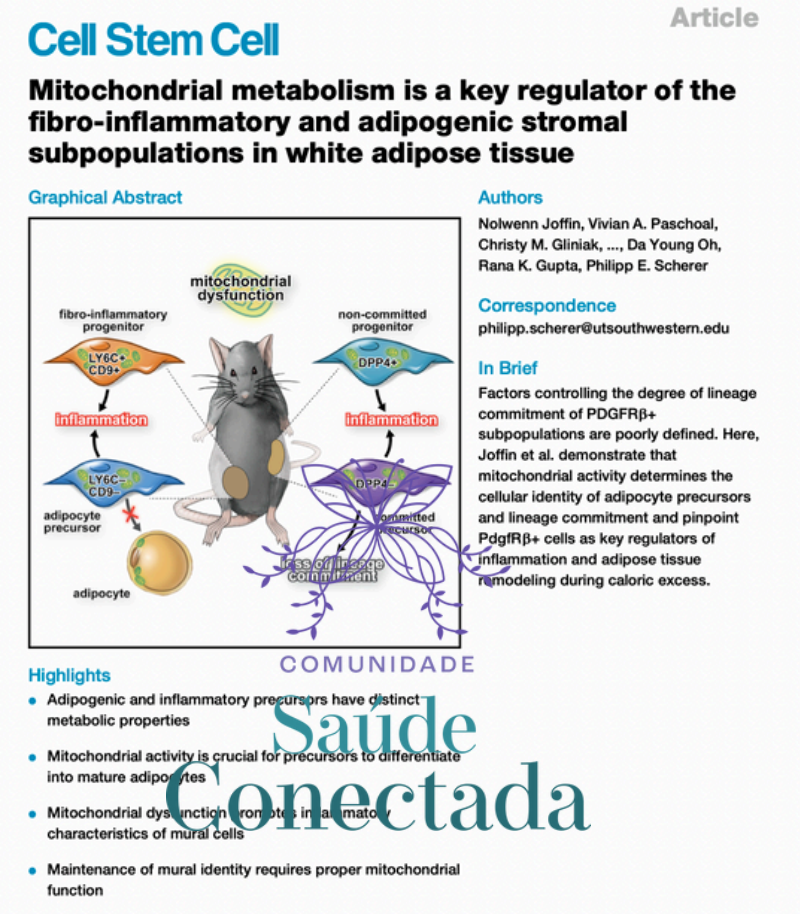
> J Obes. 2023 Nov 18:2023:5826630. doi: 10.1155/2023/5826630. eCollection 2023.

The Benefits of Low-Carbohydrate, High-Fat (LCHF) Diet on Body Composition, Leg Volume, and Pain in Women with Lipedema

> Nutrients. 2023 Aug 20;15(16):3654. doi: 10.3390/nu15163654.

Modified Mediterranean-Ketogenic Diet and Carboxytherapy as Personalized Therapeutic Strategies in Lipedema: A Pilot Study

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Article

Cell Stem Cell

Mitochondrial metabolism is a key regulator of the fibro-inflammatory and adipogenic stromal subpopulations in white adipose tissue

Graphical Abstract

Authors

Nolwenn Joffin, Vivian A. Paschoal, Christy M. Gliniak, ..., Da Young Oh, Rana K. Gupta, Philipp E. Scherer

Correspondence

philipp.scherer@utsouthwestern.edu

In Brief

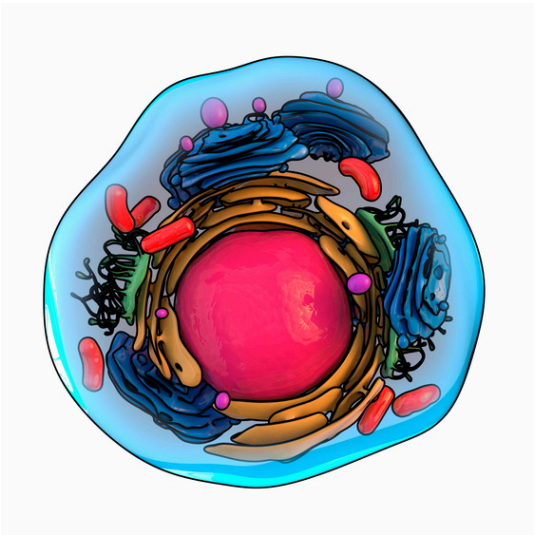
Factors controlling the degree of lineage commitment of PDGFRβ+ subpopulations are poorly defined. Here, Joffin et al. demonstrate that mitochondrial activity determines the cellular identity of adipocyte precursors and lineage commitment and pinpoint PdgfRβ+ cells as key regulators of inflammation and adipose tissue remodeling during caloric excess.

Highlights

- Adipogenic and inflammatory precursors have distinct metabolic properties
- Mitochondrial activity is crucial for precursors to differentiate into mature adipocytes
- Mitochondrial dysfunction promotes inflammatory characteristics of mural cells
- Maintenance of mural identity requires proper mitochondrial function

COMUNIDADE Saúde Conectada

Nutrir as mitocôndrias



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

› Cureus. 2023 Jul 9;15(7):e41594. doi: 10.7759/cureus.41594. eCollection 2023 Jul.

Assessing the Prevalence of HLA-DQ2 and HLA-DQ8 in Lipedema Patients and the Potential Benefits of a Gluten-Free Diet

Alexandre C Amato [1], Lorena L Amato [2], Daniel Benitti [3], Juliana L Amato [4]

A presença de qualquer HLA associado à doença celíaca (HLA-DQ2+ ou HLA-DQ8+) foi de 61,1% nos pacientes com lipedema. Em comparação com a população geral, houve uma prevalência significativa.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

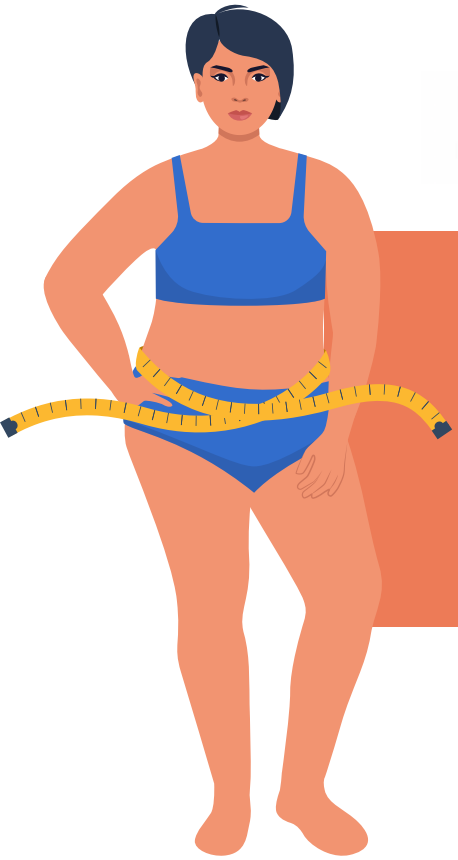
Review > J Prev Med Hyg. 2022 Oct 17;63(2 Suppl 3):E169-E173.
doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2S3.2758. eCollection 2022 Jun.

Dietary supplements for lipedema

Lipedema is a chronic disease that mostly manifests in females as the abnormal distribution of subcutaneous adipose connective tissue, usually coupled with bruising, pain, and edema. Lipedema molecular pathophysiology is currently not clear, but several studies suggest that genetics and hormonal imbalance participate in lipedema pathogenesis. Women with lipedema present in some cases with elevated body mass index, and the appearance of obesity in addition to lipedema, where the obesity can cause serious health issues as in lipedema-free individuals with obesity, such as diabetes and cardiovascular disorders. Unlike obesity, lipedema tissue does not respond well to diet or physical exercise alone. Therefore, in this review we discuss the effect of various dietary supplements that, along with diet and physical exercise, cause fat burning and weight loss, and which could potentially be important in the treatment of lipedema. Indeed, an effective fat burner should convert stored fats into energy, mobilize and break down triglycerides in adipocytes, boost metabolism and inhibit lipogenesis. Common ingredients of fat burning supplements are green tea, caffeine, chromium, carnitine, and conjugated linoleic acid. The use of fat burners could act synergistically with a healthy diet and physical exercise to decreasing adipose tissue deposition in patients with lipedema and resolve related health issues. The effects of fat burners in human studies are sometimes contradictory, and further studies should test their effectiveness in treating lipedema.

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Nutritional Supplements and Lipedema: Scientific and Rational Use

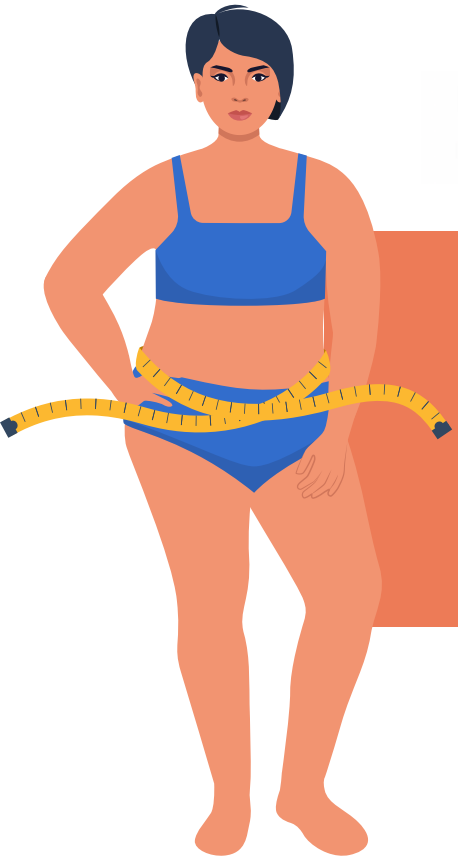
by Roberto Cannataro [1,2,3] and Erika Cione [1,2,*]

COMUNIDADE

Saúde Conectada

- Chá verde
- Cafeína
- Cromo
- L Cartinina
- Ômega 3
- Polifenóis
- Vitamina C

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Nutritional Supplements and Lipedema: Scientific and Rational Use

by Roberto Cannataro [1,2,3] and Erika Cione [1,2,*]

COMUNIDADE

Saúde Conectada

- Quercetina
- Cúrcuma
- Coenzima Q10
- Astaxantina
- Cactínea
- Luteína
- Vitamina E

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Chá verde

Dosagem e Modo de usar

- Infusão (rasura): (5%) 3 a 4 doses diárias;
- Tintura: 15 gotas até três vezes ao dia.
- Extrato seco 50%: 200 a 500 mg duas vezes ao dia. (Tomar até no máximo as 16 horas);

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

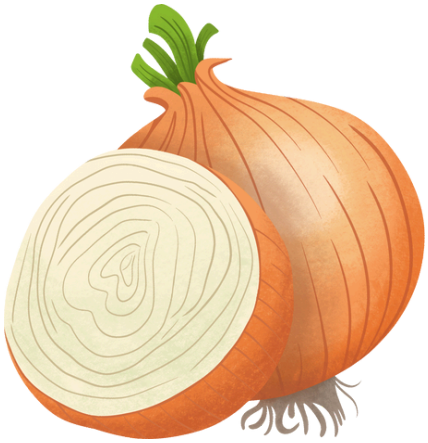
Quercetina

- Extrato seco (95%): 400 a 500mg por via oral, três vezes ao dia.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Cactinea - Opuntia ficus indica

- Extrato seco padronizado (10% Betalaína e 0,06% Indicaxantina): 500mg a 1,5g ao dia após o café da manhã



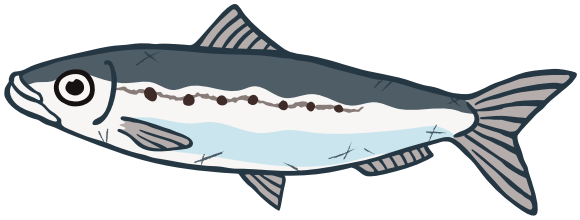
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ômega 3

Melhora a resistência a insulina, diminui inflamação, aumenta HDL, estimula a biogênese mitocondrial.
DOSE: 2 a 3g por dia (somando a quantidade de EPA + DHA).

Ex: se em 3 cápsulas tem 990mg de EPA e 660mg de DHA que fornece um total de 1650mg. Então é recomendável ingerir 4 cápsulas ao dia (2 no almoço e 2 no jantar).

Saúde Conectada



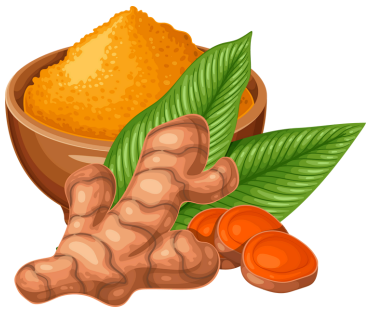
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Cúrcuma

Curcuma Longa padronizada extrato (mínimo de 95% de curcuminóides) - 250mg
Piper nigrum (pimenta preta) - 5mg

Tomar 1 dose 2x ao dia, próximo as refeições.
Duração: pelo menos 3 meses.

COMUNIDADE
Saúde Conectada



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Diosmina + Hesperidina

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Diosmina é um bioflavonóide, antivaricoso sistêmico e vasoprotetor utilizado no tratamento dos distúrbios venosos e da circulação periférica. A hisperidina também é um bioflavonóide. Encontrada na porção branca dos limões e laranjas verdes. Tem sido usada no tratamento da fragilidade capilar.

Diosmina 450mg
Hesperidina 50mg
Tomar 1 dose 2x ao dia, junto as refeições.
Duração: pelo menos 6 meses ou de acordo com a prescrição médica.

Contraindicações: hipersensibilidade (alergia) à diosmina e/ou hisperidina ou qualquer um dos componentes da fórmula.
Não é indicado para menores de 18 anos.
Não deve ser utilizado por mulheres grávidas.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Diosmina 450mg
Hesperidina 50mg
Rutina 100mg
Centella asiática 150mg
Tomar 1 dose 2x ao dia, junto as refeições.
Duração: pelo menos 6 meses ou de acordo com a prescrição médica.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

A Rutina é um bioflavonóide encontrado nos vegetais folhosos e frutas cítricas. Seu uso é de grande importância para prevenir o aparecimento de microvarizes e problemas vasculares.
Centella Asiática é uma erva medicinal rica em compostos bioativos. Possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, cicatrizantes e diurética, promovendo a regeneração da pele, a redução da inflamação, o fortalecimento dos vasos sanguíneos e redução do inchaço. Também é muito utilizada no tratamento contra estrias e celulite por aumentar a produção de colágeno.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

DI-INDOL METANO

100mg
Tomar 1 dose 2x ao dia, manhã e noite.
Duração: pelo menos 3 meses.

É um composto natural presente em plantas alimentícias do gênero Brassica, incluindo brócolis, repolho, couve de bruchelas, couve-flor e couve.
DIM promove o metabolismo estrogênico saudável, protegem contra o estresse oxidativo e otimizando as vias de desintoxicação hepática.
Além de ter ação anti-inflamatória e antioxidante.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

D-GLUCARATO DE CÁLCIO (CDG)

500mg
Tomar 1 dose 2x ao dia, com as refeições.
Duração: pelo menos 3 meses.

O CDG é produzido naturalmente em pequenas quantidade no corpo; também é encontrado em diversas frutas e vegetais: laranjas, brócolis, cenouras, espinafre e maçãs.
Ele aumenta a eliminação de estrogênio por reduzir a atividade da enzima beta-glucuronidase no intestino, impedindo a reaborção do hormônio.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

DIM (Di-Indol Metano) 100mg
D-Glucarato de Cálcio 100mg
Ácido alfa lipóico 100 mg
N-acetil-L-cisteína 200mg
L-metionina 200 mg
Glicina 100 mg
Taurina 100 mg

COMUNIDADE
Saúde Conectada

EXAMPLE

Tomar 1 dose 2x ao dia, com as refeições.
Duração: 3 a 4 meses.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Curcuma Longa padronizada extrato (95% de curcuminóides) - 250mg
Piper nigrum (pimenta preta) - 5mg
Pinus Pinaster extrato seco padronizado a 95% - 150mg
Quercetina ex trato seco padronizado a 95% - 250mg

Tomar 1 dose 2x ao dia, próximo as refeições.
Duração: 3 a 4 meses.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

MELHORA DA CIRCULAÇÃO E INCHAÇO

Diosmina + hisperidina + associações

EQUILÍBRIO DO ESTROGÊNIO

Di-Indol Metano OU D-Glucarato de Cálcio + associações

REDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO

Ômega 3 OU curcumina OU Quercetina + associações

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SUPLEMENTOS

Como usá-los

COMUNIDADE Saúde Conectada

Escolher de 3 a 4 ativos, usar por 3 meses e depois rotacionar com outros

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Chás

- Hibisco
- Cavalinha
- Gengibre
- Dente de leão
- Camomila
- Chá verde
- Capim limão
- Canela
- Rooibos

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE

EXAMES Saúde Conectada

> Nutrients. 2020 Apr 25;12(5):1211. doi: 10.3390/nu12051211.

Selenium Deficiency in Lymphedema and Lipedema-A Retrospective Cross-Sectional Study from a Specialized Clinic

> Horm Mol Biol Clin Investig. 2021 Jul 29;42(4):351-355. doi: 10.1515/hmbci-2021-0027.

The association between serum vitamin D and mood disorders in a cohort of lipedema patients

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

PREDOMINÂNCIA ESTROGÊNICA

COMUNIDADE Saúde Conectada

Review > Int J Mol Sci. 2021 Oct 29;22(21):11720. doi: 10.3390/ijms222111720.

Lipedema and the Potential Role of Estrogen in Excessive Adipose Tissue Accumulation

Kaleigh Katzer [1], Jessica L Hill [1], Kara B McIver [1], Michelle T Foster [1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review. J Dermatol Ther. 2021 Jan;34(1):e14364. doi: 10.1111/dth.14364. Epub 2020 Oct 12.

Cause and management of lipedema-associated pain

Hasan Akbas [1], Ayse Serap Karadag [1], Uwe Wollina [2]

Affiliations [1] expand

PMID: 33001552 DOI: 10.1111/dth.14364

Abstract

Lipedema is a painful, underdiagnosed adipose tissue disorder, characterized by symmetrical swelling of the extremities due to subcutaneous fat deposition in the buttocks, thighs, legs, and arms, sparing the most distal part of the extremities. Although etiology and pathogenesis of lipedema is unclear, possible role of hormonal and genetic factors have been proposed previously. Patients with lipedema suffer from pain, easy bruising, tenderness, and disfigurement. Pain is the leading symptom in lipedema. Since the pain is associated with depression and impaired quality of life, reduction of pain is the major therapeutic approach. Pain in lipedema is attributed to allodynia, exaggerated sympathetic signaling, and estrogens. Although the mechanism of pain in lipedema is uncertain, effective treatment of lipedema should provide a satisfactory pain reduction. Efficacy of the conservative treatment is a matter of debate. Microcannular tumescent liposuction is the most effective therapeutic option for lipedema. There is a large body of evidence that this procedure significantly reduces pain in patients with lipedema.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Biomed Res Int. 2014:2014:757461. doi: 10.1155/2014/757461. Epub 2014 Mar 6.

Estrogen Deficiency and the Origin of Obesity during Menopause

Fernando Lizcano [1], Guillermo Guzmán [2]

Affiliations + expand

PMID: 24734243 PMCID: PMC3964739 DOI: 10.1155/2014/757461

Free PMC article

COMUNIDADE Saúde Conectada

Abstract

Sex hormones strongly influence body fat distribution and adipocyte differentiation. Estrogens and testosterone differentially affect adipocyte physiology, but the importance of estrogens in the development of metabolic diseases during menopause is disputed. Estrogens and estrogen receptors regulate various aspects of glucose and lipid metabolism. Disturbances of this metabolic signal lead to the development of metabolic syndrome and a higher cardiovascular risk in women. The absence of estrogens is a clue factor in the onset of cardiovascular disease during the menopausal period, which is characterized by lipid profile variations and predominant abdominal fat accumulation. However, influence of the absence of these hormones and its relationship to higher obesity in women during menopause are not clear. This systematic review discusses of the role of estrogens and estrogen receptors in adipocyte differentiation, and its control by the central nervous systemn and the possible role of estrogen-like compounds and endocrine disruptors chemicals are discussed. Finally, the interaction between the decrease in estrogen secretion and the prevalence of obesity in menopausal women is examined. We will consider if the absence of estrogens have a significant effect of obesity in menopausal women.

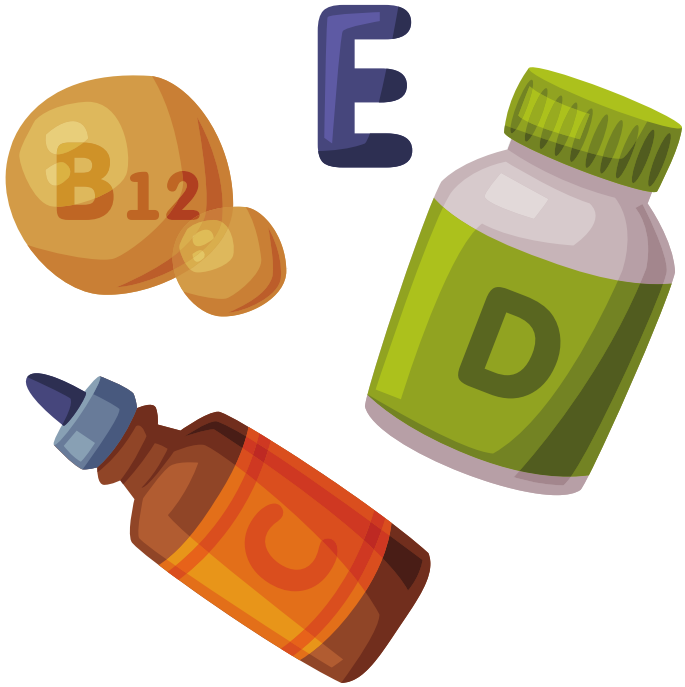
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

MEDICAMENTOS

OBESIDADE

COMUNIDADE
Saúde Conectada

- Topiramato
- Bupropiona + nalterexona
- Fluoxetina
- Saxenda, Ozempic, Trulicity, Wegovy



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

JAMA | Review

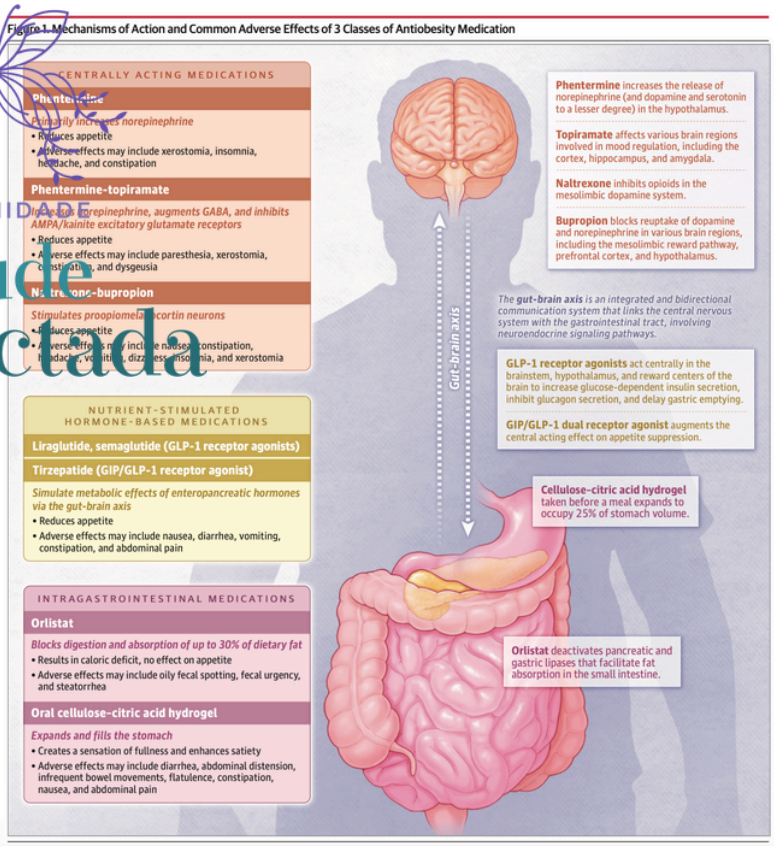
Medications for Obesity
A Review

Kimberly A. Gudzune, MD, MPH; Robert F. Kushner, MD, MS

COMUNIDADE Saúde Conectada

JAMA. doi:10.1001/jama.2024.10816
Published online July 22, 2024.

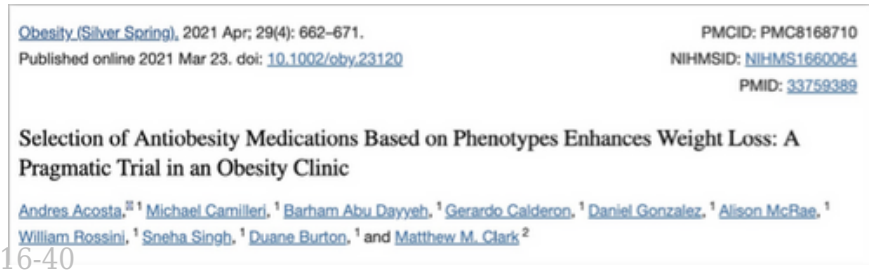
Figure 1. Mechanisms of Action and Common Adverse Effects of 3 Classes of Antiobesity Medication



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Fome cerebral - compulsão alimentar
Fome emocional - gatilho emoção
Saciedade anormal
Metabolismo lento



Obesity (Silver Spring). 2021 Apr; 29(4): 662–671.
Published online 2021 Mar 23. doi: 10.1002/oby.23120
PMCID: PMC8168710
NIHMSID: NIHMS1660064
PMID: 33759389

Selection of Antiobesity Medications Based on Phenotypes Enhances Weight Loss: A Pragmatic Trial in an Obesity Clinic

Andres Acosta,[1] Michael Camilleri,[1] Barham Abu Dayyeh,[1] Gerardo Calderon,[1] Daniel Gonzalez,[1] Alison McRae,[1] William Rossini,[1] Sneha Singh,[1] Duane Burton,[1] and Matthew M. Clark[2]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Curr Obes Rep. 2019 Jun;8(2):156-164. doi: 10.1007/s13679-019-00335-3.

Metformin: Mechanisms in Human Obesity and Weight Loss

Armen Yerevanian [1 2 3], Alexander A Soukas [4 5 6]

> Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2013 Jan;121(1):27-31. doi: 10.1055/s-0032-1327734. Epub 2012 Nov 12.

Effectiveness of metformin on weight loss in non-diabetic individuals with obesity

C Seifarth [1], B Schehler, H J Schneider

COMUNIDADE Saúde Conectada

É um antidiabético oral que suprime a rota pela qual é produzida a glicose hepática e melhora a captação periférica de glicose em nível hepático e no músculo esquelético.

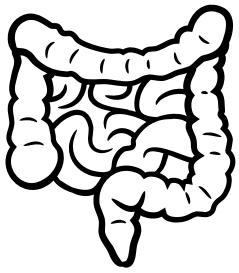
Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Mol Metab. 2023 Nov:77:101805. doi: 10.1016/j.molmet.2023.101805. Epub 2023 Sep 9.

Effects of metformin on the gut microbiota: A systematic review

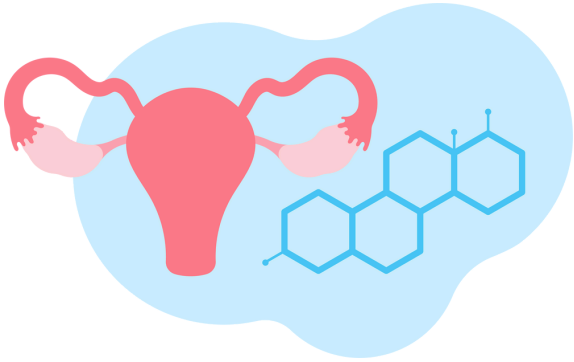
Pavlo Petakh [1], Iryna Kamyshna [2], Aleksandr Kamyshnyi [3]

COMUNIDADE Saúde Conectada



Review > Expert Rev Clin Pharmacol. 2021 Jan;14(1):121-130. doi: 10.1080/17512433.2021.1863788. Epub 2020 Dec 21.

Effects of metformin on body weight in polycystic ovary syndrome patients: model-based meta-analysis



Review > Cancers (Basel). 2022 Jan 24;14(3):577. doi: 10.3390/cancers14030577.

Metformin as a Potential Treatment Option for Endometriosis

Żaneta Kimber-Trojnar [1], Dominik Franciszek Dłuski [1], Magdalena Wierzchowska-Opoka [1], Monika Ruszała [1], Bożena Leszczyńska-Gorzelak [1]

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Relatórios de Caso > Representante do caso Dermatol.2012 Sep;4(3):222-6.
doi: 10.1159/000342073. Epub 2012 23 de outubro.

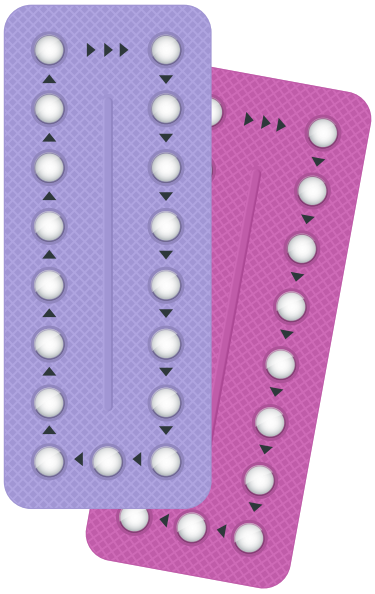
COMUNIDADE
Saúde
Conectada

A linfostase é um agravante do lipedema?

Maria de Fátima Guerreiro Godoy [1],Edivandra Buzato,Patricia Amador Franco Brigidio,
José Maria Pereira de Godoy

Afiliações + expandir

PMID: 23185156 PMCID: PMC3506057 DOI: 10.1159/000342073



Resumo

Uma paciente de 54 anos relatou que uma característica de sua família eram 'pernas gordas' com edema postural desde a adolescência. Ao longo dos anos, o paciente estava ganhando peso com um aumento no tecido adiposo nas pernas e braços. Aos 24 anos, ela começou a tomar contraceptivos orais e notou pior inchaço e dor nos membros inferiores. Ela foi aconselhada a suspender o uso dos contraceptivos e começar a usar um medicamento do sistema linfático transdérmico e exercício físico que melhorou parcialmente os sintomas. Há três anos, ela observou que o inchaço estava aumentando sem melhora e procurou um médico que levantou a hipótese de linfedema e a encaminhou para um centro especializado. Lipedema e linfedema foram diagnosticados no exame físico. Um programa de tratamento intensivo de 3 dias (8 h por dia) foi iniciado para linfedema, que incluiu drenagem linfática manual e mecânica associada a meias de compressão de curto prazo (<50 mm Hg) feitas sob medida usando um tecido de algodão-poliéster. Volumetria e perimetria foram realizadas antes do início e depois do tratamento e as pernas foram fotografadas. Foram obtidas reduções volumétricas e perimétricas, sugerindo o envolvimento da linfostase cutânea regional nesta doença.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

MENTE

CORPO E ALMA

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct 21;19(20):13679. doi: 10.3390/ijerph192013679.

The Difficulties in Emotional Regulation among a Cohort of Females with Lipedema

COMUNIDADE Saúde Conectada

Background: Lipedema is a chronic and progressive adipose tissue disorder that causes significant morbidity and negatively influences mental health and quality of life, and increases the risk of depression, anxiety, and eating disorders. One construct of relevance to better understanding psychological disorders is emotion regulation (ER). Therefore, the aim of this study is to investigate the difficulties in ER among lipedema patients compared to healthy people without lipedema.

Methods: This cross-sectional study assessed differences in ER and anxiety between two groups: 26 female patients with lipedema and 26 sex- and age-matched healthy controls. The Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) assessed emotional regulation across six dimensions: Impulse control, goal-directed behavior, awareness, clarity, non-acceptance, and strategies. Anxiety was assessed by the Hamilton Anxiety Scale (HAM-A). ANOVA assessed differences in measures between lipedema and healthy control groups.

Results: Lipedema patients presented with significantly more difficulties in ER and a higher level of anxiety than those without lipedema. Specifically, the lipedema group showed higher and significant differences in total DERS and anxiety scores and all DERS subscales scores compared to those without lipedema.

Conclusions: Lipedema patients showed significant difficulties with ER, and were associated with anxiety symptoms, indicating that ER difficulties may play a role in developing emotional disorders, such as anxiety, for patients with lipedema. The health care provider should pay more attention to ER difficulties and psychological status among lipedema patients.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

COMUNIDADE
Saúde Conectada

A gordura representa a proteção da repressão externa, um freio aos seus sentimentos mais íntimos. Pessoas obesas gostam de parar em alguma coisa (situação, modo de vida) e são muito relutantes em mudar hábitos e padrões comportamentais e também emocionais. Apego.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Lymphat Res Biol. 2024 Feb;22(1):3-7. doi: 10.1089/lrb.2023.0038. Epub 2023 Dec 22.

Prevalence of Fibromyalgia Syndrome in Women with Lipedema and Its Effect on Anxiety, Depression, and Quality of Life

COMUNIDADE Saúde Conectada

A gordura, na obesidade, reflete a necessidade de defesa e proteção, um sentimento de vazio e insegurança, bem como a dificuldade de viabilizar os planos.

Gordura localizada representa um estado de estar se poupando da livre expressão, a condição de não deixar fluir a sua capacidade articuladora, a criatividade e flexibilidade; a gordura localizada no abdome representa a postura em defender-se do ambiente, o medo de ser afetado pelas situações nocivas que estão a sua volta.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Outro fator é a negação das suas vontades, repressão dos seus impulsos. Gordura localizada representa estar se poupando da expressão própria mais autêntica, não deixando fluir a sua capacidade articuladora.

O acúmulo de gordura no culote ou ancas representa falta de jogo de cintura nas situações práticas do cotidiano e a contenção da impulsividade; gordura localizada nos braços, diz respeito às dificuldades diante de suas tarefas.

O corpo, como tudo na vida, é um **espelho** de nossos pensamentos e crenças internas. Cada célula de nosso corpo responde a cada pensamento que pensamos e a cada palavra que pronunciarmos. Nutrindo a célula, oferecemos a saúde necessária para manter a nutrição metafísica.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40